

Findings de la fondoscopie dans le décollement de la rétine		Décollement rétinien rhéomatogène	Décollement rétinien tractionnel	Décollement rétinien exsudatif (séreux)
Épidémiologie		- Le plus commun et plus commun chez : - les personnes âgées - les hommes - l'OD - Facteurs de risques : - Chirurgie intraoculaire antérieure (e.g., cataracte) - Décollement de la rétine de l'autre œil - Brèches rétiniennes, souvent dues à : - Myopie - Traumatisme	- Souvent associé à des rétinopathies prolifératives : - Rétinopathie diabétique proliférative - Rétinopathie du prématuré - Rétinopathie falciforme - Effusions Inflammation : Toxoplasmose	- Associé à des maladies systémiques : - Prééclampsie - Hypertension - Maladies oculaires : - Rétinite séreuse centrale - Occlusion veineuse rétinienne centrale - Croissance tumorale
Étiologie		- Déchirures rétiniennes → le liquide vitréen s'infiltre dans l'espace sous-rétinien → décollement de la rétine (détachement postérieur du vitré)	- Formation de bandes vitréo-rétiniennes - Traction sur la bande vitréo-rétinienne (lors des mouvements oculaires ou suite à soudaine de la PIO) → décollement de la rétine - Pas de déchirures rétinienne	- Accumulation d'exsudats sous-rétiniens sans déchirures rétinienne - Caractéristiques de l'étiologie sous-jacente (e.g., tumeur choroïdienne) peuvent être présentes
Caractéristiques de la rétine décollée		Convexe avec une surface ridée qui ondule avec les mouvements oculaires	Concave ou tendue, immobile	Convexe avec une surface lisse
Liquide sous-rétinien		Présent	Minime ou absent	Présent et bouge lorsque le patient change de position (dépendant de la gravité)
Prise en charge		- Trouver et traiter les déchirures rétiniennes par photocoagulation au laser ou cryo-rétinopexie - Chirurgie (rétinopexie pneumatique, indentation sclérale, vitrectomie pars plana) si décollement étendu	- Vitrectomie avec ou sans indentation sclérale	- Traitement de la cause sous-jacente - Chirurgie rarement nécessaire

	Uvéite postérieure		Uvéite intermédiaire	Uvéite antérieure
Épidémiologie	- La 2^{ème} plus fréquente		- Moins fréquente	- La plus fréquente
Structures affectées	- Choroïde (choroïdite) - Rétine (rétinite, choroïdorétinite)		- Vitré (vitrite) - Partie postérieure du corps ciliaire (pars plana)	- Iris (irite) - Corps ciliaire (iridocyclite, ou cyclite)
Caractéristiques cliniques	- Troubles visuels indolores - Mouches flottantes - Scotome - Vision floue			- Douleur progressive périoculaire sourde - Hyperémie oculaire (œil rouge) - Photophobie - Vision floue - Épiphora - Récurrences fréquentes
Examen complet de l'œil	- AV : diminuée - Lampe à fente : leucocytes dans l'humeur vitréenne - FO : foyers d'inflammation : - de la choroïde - et/ou de la rétine		- AV : diminuée - Lampe à fente : leucocytes dans l'humeur vitréenne - FO : foyers d'inflammation : - du vitré	- Injection ciliaire (hyperhémie des vaisseaux entourant la cornée) - Examen pupillaire : myosis - AV : diminution légère/modérée - Lampe à fente : - Leucocytes dans la chambre antérieure - Cellules et flare - Précipités kératiques sur l'endothélium cornéen - Hypopyon - Nodules iridiens
Traitement	Stéroïdes topiques OU systémique			Unilat. : Stéroïdes topiques Bilat. : Stéroïdes systémique
Complications	- Perte du champ visuel due aux cicatrices - Perte majeure de l'acuité visuelle, si la macula est affectée		- Synéchies postérieures - Perte du champ visuel due aux cicatrices	- Synéchies postérieures (adhérences entre l'iris et le cristallin) - Synéchies antérieures (adhérences entre l'iris et la cornée ou le trabéculum) - Glaucome à angle ouvert - Cataracte